

SP

类型 T1：配合型

核心特征：积极合作，回答清晰准确，情绪稳定，不制造额外沟通障碍。

阶段	情绪	反应（含正常行为与特殊情境反应）
阶段1： 准备与角色内化	平静，略带对病情的合理担忧（非对医生的不信任），面部表情平和但有轻微眉头微皱。	安静坐好，姿势放松，目光平稳注视医学生，点头回应自我介绍。对开放式问题给出完整主诉，主动说出核心症状，不刻意隐瞒或夸大。语气自然，语速适中。
阶段2： 现病史采集	谈论症状时表现出适当的痛苦和担忧，但不夸张。说到体重下降时声音自然降低，流露出一丝难过。	用手准确指示疼痛位置，配合手势描述疼痛性质，回答时身体前倾表示配合。对每个追问给出教案中的准确细节。 对复合问题： 稍停顿，但依然努力回答每一部分，不抱怨。 对专业术语： 若理解则直接回答，不理解则平静请求解释。
阶段3： 既往史与背景信息	回忆时平静，无额外情绪波动。	坐直，认真回忆，目光微微上移。被问及用药史时主动说出药名；被问及家族史时直接回答；不主动展开无关信息。
阶段4： 系统回顾	平静，无焦虑或烦躁。	快速、简短回答，每次回答后等待下一个问题。对每个系统问题回答“有”或“没有”，不加额外解释。
阶段5： 关怀与总结	被共情时表现出被理解的轻松感；总结有误时温和纠正，不带情绪。	仔细听医学生总结，适时点头或摇头，对共情语言放松肩膀或微笑。如发现总结错误，平静指出正确信息。对下一步计划表示接受，可适当提问但不纠缠。

类型 T2：焦虑型

核心特征：紧张、坐立不安、语速快、反复确认、易哭，对每句话都担心“严不严重”。

阶段	情绪	反应（含正常行为与特殊情境反应）
阶段1： 准备与角色内化	高度焦虑，嘴唇微颤，声音发紧，呼吸稍急促。	坐立不安，双手反复搓揉或抓衣角，脚轻轻点地。眼睛四处看，不敢直视医学生，身体微微前倾或蜷缩。医学生自我介绍时简短回应，目光闪烁。主诉时语速偏快，主动插入对病情严重性的担忧。
阶段2： 现病史采集	紧张，声音颤抖，接近哭腔。对每个症状描述后都表现出对“是否严重”的过度关注。	不停搓手或捏手指，眼神求助般频繁看向医学生。每次回答后身体后仰又前倾。回答每个症状细节后主动反问“这正常吗？”“是不是很严重？” 对复合问题 ：表现出慌乱，可能只回答第一个问题，或请求医学生重复。 对生硬提问 ：更加焦虑。
阶段3： 既往史与背景信息	持续焦虑，对每个信息都赋予负面解读。声音颤抖持续。	不停观察医学生表情，试图从中判断病情。手部动作持续。提到药物时反问副作用；提到家族史时表现出对自己患病的恐惧。对任何信息都表现出“这会不会导致坏结果”的担忧。
阶段4： 系统回顾	对每个系统问题都表现出紧张，特别是被问到与主诉可能相关的系统（如体重、食欲）时。	身体前倾，每回答一个系统问题都看医学生一眼寻求确认。对每个“有”的回答后可能补充“这有关系吗？”。语速不稳定，时快时慢。
阶段5： 关怀与总结	被共情时情绪有所缓解（肩膀放松），但焦虑不会完全消失。总结有误时以紧张语气纠正。	医学生共情时身体放松一些，可能点头或叹气。总结时仔细听但表情仍紧张。对下一步计划表现出接受但有顾虑，可能问“会很疼吗？”“要住院吗？”语气仍紧张。

类型 T3：愤怒/敌对型

核心特征：抱怨、指责、不信任、语气冲，对医疗系统或过往就医经历有怨气。

阶段	情绪	反应（含正常行为与特殊情境反应）
阶段1： 准备与角色内化	不满、不耐烦、怀疑，面部表情紧绷，嘴角下拉。	双臂交叉抱胸，身体后仰，眼神带有审视或不信任感。医学生自我介绍时无回应或冷淡点头。主诉时用抱怨语气，可能先指责“你们医生都差不多”，然后才说症状。语速偏快，声音较大。
阶段2： 现病史采集	愤怒，对每个问题都可能附带抱怨（如“问这么多有什么用”），但不至于中断问诊。	身体后仰或不面对医学生，回答时夹带叹气、摇头，可能用手指敲桌面。回答症状细节时夹带对过往就医经历的不满。 对复合问题 ：可能直接说“你问得太多了”。 对专业术语 ：可能攻击“别说那些我听不懂的”。
阶段3： 既往史与背景信息	持续敌对，对用药史等问题可能抱怨“以前医生开的药没用”。	回答问题时不看医学生，或翻白眼。身体姿态防御性。提到药物时指责效果不好；提到家族史时简短回答，不主动展开。语气始终带有不满。
阶段4： 系统回顾	烦躁，觉得被冒犯或浪费时间。	快速、不耐烦地回答，可能反问“问这些跟我胃病有什么关系”。每个系统问题都快速回答“没有”或“有”，并附加“你问完了没有”之类的不耐烦语句。
阶段5： 关怀与总结	对共情不信任，认为“说这些没用”。总结有误时以愤怒语气纠正。	医学生共情时不一定买账，可能冷哼或不回应。总结时如果医学生态度好，可能稍缓和。对下一步计划可能质疑“真的有用吗？上次也这么说”。但如果医学生始终保持专业且不防御，愤怒可能逐渐降级。

类型 T4：抑郁/淡漠型

核心特征：语速慢、声音低、无精打采、回答简短、缺乏动力。

阶段	情绪	反应（含正常行为与特殊情境反应）
阶段1： 准备与角色内化	低落、无望、缺乏活力。面部表情平淡，无明显情绪变化。	身体沉闷，弯腰驼背，头微低，眼神呆滞或看地面。医学生自我介绍时反应迟钝，很久才回应。主诉时声音低沉，语句很短，不主动展开。
阶段2： 现病史采集	淡漠，对病情的担忧不表现出来，似乎“无所谓”。声音轻，听不清楚可能需要医学生靠近。	几乎不配合肢体动作，手势极少。每次回答前有较长停顿。每个回答都用最短语句，如“疼”“烧灼感”“吃完饭后”。不主动提供额外信息。 对复合问题 ：只回答第一个。 对术语 ：可能不回应，或说“不知道”。
阶段3： 既往史与背景信息	无情绪波动，像在机械回答。	回答慢，每个问题后停顿2-3秒，目光呆滞。用药史回答“吃过”“忘记了”。家族史回答“我爸胃癌”后不再展开。不主动提供任何信息。
阶段4： 系统回顾	冷漠，可能透露出“无所谓”的态度。	对每个问题都慢吞吞回答，身体不动。每个系统问题后停顿几秒，然后说“没有”或“有”。对“有”的回答也不主动描述。
阶段5： 关怀与总结	外表仍淡漠，但医学生真诚的共情可能让眼神稍亮。	对共情没有明显反应（不点头、不放松），但内心可能会被触动。总结时被动听，不主动纠正错误。对共情回应“嗯”或无回应。总结有误时可能不纠正，或轻声说“不对”。对下一步计划无反应，不提问。

类型 T5：认知障碍型（早期痴呆）

核心特征：记忆力差、重复、定向力障碍、时间线混乱、回答前后可能矛盾。

阶段	情绪	反应（含正常行为与特殊情境反应）
阶段1： 准备与角色内化	困惑为主，偶尔因记不住而沮丧，但不到愤怒。	坐姿正常但眼神略显迷茫。开场时可能忘记医学生已自我介绍，或重复问“你是谁”。主诉时可能说了症状但时间顺序混乱，或跑题。医学生自我介绍后可能很快忘记名字。
阶段2： 现病史采集	困惑、偶尔挫败。	用手指位置时可能指错，然后纠正。回答时频繁停顿。时间信息混乱（如“上周？上个月？我记不清了”）。 对同样的问题： 可能给出不同答案。经常重复自己刚说的话。 对复合问题： 只回答最后一句或第一句。 对术语： 表示“不懂”，且学了也记不住。
阶段3： 既往史与背景信息	因记不住而沮丧、自责。	回答时努力回忆但经常失败。用药史可能说错药名、剂量、时间。家族史可能记得但细节模糊。 被追问： 可能给出矛盾信息（如先否认有高血压，过一会儿又说有）。
阶段4： 系统回顾	困惑加剧，可能回避回答。	对每个问题的回答可能前后不一致。对同样系统问题在不同时间回答不同。对“有”的症状可能无法描述。
阶段5： 关怀与总结	对共情有短暂的理解和感激，但很快可能忘记。	医学生总结时可能不记得自己说过什么，纠正或不纠正取决于当天状态。对共情点头但很快回到迷茫。总结有误时可能不纠正，因为忘记了自己说过什么。对下一步计划可能反复问同样的问题（如“做胃镜？为什么要做胃镜？”）。

类型 T6：语言/文化障碍型

核心特征：词汇有限、听不懂医学术语、可能使用非母语或方言、需简化或重复。

阶段	情绪	反应（含正常行为与特殊情境反应）
阶段1： 准备与角色内化	紧张（怕听不懂）、尴尬（怕说错）、感激（当被耐心等待时）。	眼神表现出努力理解但明显吃力，可能身体前倾，皱眉。医学生自我介绍时缓慢点头。主诉时用简单词句，可能语法不完整，或夹杂方言/非母语词汇。
阶段2： 现病史采集	对听不懂的词表现出明显困惑（皱眉、睁大眼睛、摇头）。	用手势辅助说明（如指位置、比划大小）。回答时频繁看医学生表情，确认对方是否理解。 对医学术语 ：表示不懂，用自己词汇描述（如“烫烫的”）。 对复合问题 ：只理解第一句或最后一句。可能用纸笔辅助。 对生硬或快速的提问 ：表现出更多紧张和退缩。
阶段3： 既往史与背景信息	对说不出的词感到沮丧。	回答慢，需要时间组织语言。用药史可能说不出药名，但能描述药丸的颜色形状。家族史用简单句回答。被追问细节时因词汇不足而卡住。
阶段4： 系统回顾	紧张加重，因为系统回顾有很多不同术语。	对每个词都努力理解。对听不懂的术语要求解释（如“什么叫做心悸？”）。回答“有”或“没有”后，可能因不确定而补充“我不确定我听懂了你的问题”。
阶段5： 关怀与总结	被耐心等待时情绪缓解，但仍紧张。	医学生共情时表现出感激（点头、微笑）。总结时仔细听，但可能只理解部分。对共情回应“谢谢”。总结有误时用简单句子纠正（如“不是10斤，是20斤”）。对下一步计划说简单词语“明白”或“不明白”，需要医学生用更简单的话重述。

类型 T7：隐瞒/回避型

核心特征：回避敏感信息（饮酒、性生活、用药依从性、精神状态），转移话题或给出不完整回答。

阶段	情绪	反应（含正常行为与特殊情境反应）
阶段1： 准备与角色内化	外表平静，但被问到敏感问题时表现出紧张（吞口水、摸耳朵）。	坐姿放松但眼神偶尔游离。主诉时只说非敏感症状，主动隐瞒病因（如不讲饮酒史）。
阶段2： 现病史采集	外表镇定，但微表情（眼神闪躲、语速变化）透露心虚。	被问到诱因时，可能轻描淡写或转移话题。对敏感诱因（如饮酒、情绪应激）回答“没什么特别的”或“就正常生活”。被追问时给出模糊答案。对专业术语回避不答。
阶段3： 既往史与背景信息	紧张、防御（身体后仰、抱胸）。	对敏感问题（如饮酒量、吸烟量、性生活）回答简短，试图快速结束话题。饮酒史：“喝一点”实为大量。吸烟史：“偶尔抽”实为每天一包。用药依从性：“都按时吃”实为经常漏服。只有当医学生用非评判性语气、具体数字追问时才逐步承认。
阶段4： 系统回顾	希望医学生快点跳过这些问题。	对敏感系统（生殖、心理）快速回答“没有”，不展开。对“情绪如何”回答“正常”，对“性生活”回答“没有”。被追问时可能沉默或转移。
阶段5： 关怀与总结	对共情有积极反应。	医学生共情时稍放松。总结时自己隐瞒的信息被漏掉，不主动纠正。总结有误时只纠正非敏感信息。对敏感信息隐瞒到底，除非医学生以非指责方式再次追问。

类型 T8：过度诉说型

核心特征：话多、离题、难以打断、讲述大量与主诉无关的细节。

阶段	情绪	反应（含正常行为与特殊情境反应）
阶段1： 准备与 角色内 化	热情、甚至兴奋 （终于有人听我 说话了）。	坐姿活跃，手势多，一开场就准备好长篇讲述。主诉时不但说出核心症状，还自动展开背景故事（如“那天我去买菜……”）。医学生很难插话。
阶段2： 现病史 采集	沉浸在自己的讲 述中，不太注意 医学生是否在 听。	回答每个问题时都离题讲述相关或不相关的事件。手势丰富，身体前倾，讲得投入。问疼痛位置时，先讲无关故事两分钟后才回到主题。 对复合问题： 只回答自己记得的部分，且离题。 需要打断才能回归： 被打断时通常不会生气，而是“哦对了，你问的是……”，然后继续但可能又离题。
阶段3： 既往史 与背景 信息	投入、滔滔不 绝。	回答用药史时讲述买药经历、医生态度、家人建议等离题内容。被问“吃过什么药”时，先讲邻居推荐等无关内容三分钟后才说药名。家族史讲述时附带大量家族故事。
阶段4： 系统回 顾	继续热情回答。	每个问题都试图展开。问“有没有胸闷”时，讲述5分钟无关事件。需要打断才能继续下一个。
阶段5： 关怀与 总结	感激医生的倾 听，但控制不住 继续说话。	对共情有正向反馈，但可能被共情触发更多讲述。总结时可能不断插话补充细节。医学生总结时插话“对了还有……”，纠正时也附带故事。对下一步计划表示接受，但可能继续问离题问题。

附：SP 综合评分表（按类型）

类型	角色一致性	医学准确性	情绪表达	对错误提问的反应	反馈质量
T1 配合型	稳定	必须高	适中	不太需要	高
T2 焦虑型	焦虑真实	准确	焦虑度适度	对生硬提问更焦虑	高
T3 愤怒型	愤怒不失控	准确	愤怒不升级	对好态度可能缓和	高
T4 淡漠型	淡漠不睡着	关键点不改	全淡漠	对任何提问都淡漠	高
T5 认知障碍型	混乱有一贯模式	错误一致	困惑为主	对重复提问更困惑	高
T6 语言障碍型	语言受限	基本准确	用简单方式表达	对术语表现不懂	高
T7 隐瞒型	回避自然	最终准确	略有紧张	对直接追问可能露馅	高
T8 过度诉说型	话多但不恶意	信息含在离题中	热情/亢奋	对打断反应自然	高

阶段6：SP 反馈评估（所有类型通用）

核心任务

任务	描述
完成 Checklist	根据预设清单，逐项勾选医学生是否完成关键问诊步骤（如问了疼痛性质、呕吐性状、用药史等）。
提供口头/书面反馈	以“我作为患者当时的感受”角度，给出 2-3 个优点和 2-3 个改进点。
给出练习建议	针对具体错误，提供可操作的改进练习方案。
保持非评判性语气	不批评医学生本人，只描述行为及其影响。

各类型 SP 在第六阶段的细微差异

类型	行为（正常）与特殊反应	情绪	反馈侧重点	练习建议方向
T1 配合型	建议者正常情绪状态	友好、建设性	肯定医学生的系统性问诊，指出细微遗漏	如何更高效采集信息
T2 焦虑型	建议者正常情绪状态	温和、共情	说明“当时我因为你的某个问法更紧张了”	安抚焦虑患者的具体技巧（放慢语速、解释术语、先共情后追问）
T3 愤怒型	建议者正常情绪状态）	中立、不保留愤怒	说明“我当时为什么生气”（如被打断、术语不当）	处理愤怒患者的方法（保持冷静、不防御、确认情绪）
T4 淡漠型	建议者正常情绪状态	专业、温和	说明“我当时虽然不说话，但内心希望医生多问”	识别淡漠信号、使用短句、多给等待时间
T5 认知障碍型	恢复正常认知状态，建议者正常情绪状态	友善、耐心	说明“我当时记不住，你应该重复、总结、写给我看”	与认知障碍患者沟通的技巧（简短短句、利用家属、允许看笔记）
T6 语言障碍型	语言恢复正常，建议者正常情绪状态	感激、友善	说明“我当时听不懂哪些术语”，演示患者困惑表现	使用日常词汇、一次一问、允许手势、必要时请翻译
T7 隐瞒型	坦诚说出自己隐瞒了哪些信息，建议者正常情绪状态	坦诚、建设性	说明“我当时没说真话是因为……”，指出医学生如何用非评判性语言突破隐瞒	建立安全氛围、使用开放式具体问题（如“一周喝几次”）

类型	行为（正常）与特殊反应	情绪	反馈侧重点	练习建议方向
T8 过度诉说型	恢复正常语速，建议者正常情绪状态	友好、自知	说明“我知道我话多，你打断我是可以的”，指出医学生打断技巧是否得当	礼貌打断技巧、总结后引导回主题、用选择题代替开放式问题

SP 培训评价维度与评价方法

一、评价维度

维度 1：角色一致性

评分点	描述
稳定性	在整个问诊过程中，角色特征（年龄、语速、姿态、情绪基调）保持前后一致，不跳脱。
真实性	表演自然，不刻意、不做作，让医学生感到面对的是真实患者而非演员。
类型贴合度	符合所分配类型（如焦虑型始终焦虑，不突然变成配合型）。
角色切换能力（仅反馈阶段）	能从“患者角色”顺利切换到“评估者角色”，不将表演情绪带入反馈。

维度 2：医学准确性

评分点	描述
症状细节	准确提供教案中规定的症状信息（位置、性质、时间、缓解因素等）。
病史信息	准确提供既往史、用药史、家族史等，不主动篡改。
信息一致性	同一问题在不同时间回答一致（认知障碍类型除外，其不一致为刻意表演）。
信息边界控制	不主动提供未被问及的关键信息（配合型可适当主动，其他类型按教案）。

维度 3：情绪与行为表达

评分点	描述
情绪基调	符合所分配类型的情绪特征（如焦虑、愤怒、淡漠、热情等）。
情绪层次	情绪有合理变化（如焦虑型在被安抚后稍缓解，愤怒型被尊重后可降级）。
肢体语言	手势、姿态、眼神、面部表情符合角色设定和情绪状态。
语音特征	语速、音量、停顿、语调符合角色（如淡漠型声音低沉缓慢）。

维度 4：对错误提问的反应

评分点	描述
对复合问题的反应	是否表现出困惑、只回答部分问题、或请求重复（符合类型设定）。
对专业术语的反应	是否表现出不懂、请求解释、或用自己的话复述（符合类型设定）。
对封闭式问题的反应	是否只给出有限信息，不主动补充（符合类型设定）。
对生硬语气/态度的反应	焦虑型是否更紧张，愤怒型是否更敌对，配合型是否平静应对等。
引导性	高级要求：SP是否能在保持角色前提下，自然地“引导”医学生改进提问方式（如说“您问得有点快，我没跟上”）。

维度 5：反馈质量

评分点	描述
客观性	完成Checklist准确、无遗漏。
具体性	反馈内容有具体事例，不笼统（如“你问疼痛细节很清楚”而非“你问得很好”）。
患者视角	以“我当时感觉……”开头，不评价医学生本人。
建设性	指出问题的同时给出改进建议。
可操作性	改进建议具体、可练习（如“建议你一次只问一个问题”而非“建议你改善提问技巧”）。
语气	非评判性、尊重、专业。

二、培训改进建议矩阵（基于评分结果）

低分维度	培训建议
角色一致性低	增加角色内化练习：录音模仿、写角色日记、观看真实患者视频。
医学准确性低	加强教案背诵测试，设置“信息点抽问”练习，直到100%正确。
情绪表达不足	情绪工作坊：即兴表演练习、情绪记忆训练、呼吸与语音控制。
对错误提问反应差	设计“坏提问”专项训练，由培训师故意问复合问题、术语，训练SP自然反应。
反馈质量低	反馈话术模板练习，Checklist使用培训，以及对“非评判性语言”的专题学习。